

Aquablation (cirugía de próstata con chorro de agua)

Información para el paciente · Tratamiento sin calor y guiado por imágenes para el agrandamiento de la próstata

WARWIKI

La Aquablation es una cirugía más nueva para el agrandamiento de la próstata (HPB) que usa un **chorro de agua a alta presión y sin calor**, guiado por ultrasonido y aplicado por la uretra, para extraer con precisión el tejido que bloquea el flujo de orina. Busca aliviar la obstrucción y conservar mejor la función sexual — en estudios causó **menos eyaculación retrógrada** que la RTUP.

Acerca de este procedimiento

Con un endoscopio y una imagen de **ultrasonido** de su próstata en tiempo real, el cirujano define con exactitud qué tejido extraer. Luego un **chorro de agua controlado por robot** extrae ese tejido con precisión, sin calor. Un breve paso de cauterización controla el sangrado y después se coloca una sonda.

Por qué elegir la Aquablation

- **Guiada por imágenes y precisa**, y sirve para próstatas de distintos tamaños (incluso glándulas grandes)
- Mejora del flujo **comparable a la RTUP**
- Diseñada para **conservar la eyaculación** mejor que la RTUP

Es una opción relativamente nueva, por lo que los datos a muy largo plazo aún crecen.

APRENDA LOS TÉRMINOS

Aquablation

Extracción del tejido de la próstata con chorro de agua para la HPB.

HPB

Agrandamiento benigno (no canceroso) de la próstata.

Sin calor

Usa la presión del agua, no calor, para extraer tejido.

Guiada por ultrasonido

Una imagen en vivo permite al cirujano definir qué tratar.

Eyaculación retrógrada

Orgasmo seco — menos común tras la Aquablation que tras la RTUP.

Sonda

Un tubo que drena la vejiga uno o dos días después.

¿EN QUÉ SE DIFERENCIA DE LA RTUP? Extrae el tejido de la próstata con un **chorro de agua preciso, sin calor y guiado por ultrasonido** en lugar de un asa eléctrica. Los resultados del flujo de orina son similares a la RTUP, pero es más probable que **conservar la eyaculación**. A cambio, es más nueva, con menos datos a largo plazo, y el sangrado se controla con un breve paso de cauterización.

Cómo prepararse

- Se hace con **anestesia general o espinal** — siga las indicaciones de ayuno y de medicamentos (suspenda los anticoagulantes si se lo indican).
- Primero un **análisis de orina** para descartar infección.
- Organice quién lo lleve; prevea un tiempo corto con sonda.

Qué sucede y después

1. Está dormido o adormecido; se administran antibióticos.
2. El ultrasonido mapea la próstata y el cirujano planea el área a tratar.
3. El chorro de agua extrae el tejido; un breve paso controla el sangrado.
4. Se coloca una sonda, que suele retirarse en unos **1–2 días**; a menudo una noche en el hospital.

Espere **orina con sangre** y algo de ardor o urgencia un par de semanas; tome líquidos y evite hacer fuerza y levantar peso.

Llame a su equipo o busque atención si tiene:

- **No puede orinar** tras retirar la sonda
- **Sangrado abundante o coágulos** que bloquean el flujo
- Fiebre o escalofríos
- Sangrado que empeora en vez de mejorar

TRES COSAS PARA RECORDAR

1. La Aquablation extrae el tejido obstructivo de la próstata con un chorro de agua preciso, sin calor y guiado por ultrasonido, por la uretra.
2. Los resultados del flujo son comparables a la RTUP, con mayor probabilidad de **conservar la eyaculación**; es más nueva, así que los datos a largo plazo aún crecen.
3. El tiempo con sonda es corto. Llame si no puede orinar, hay sangrado abundante o fiebre.